



Nuansa
Fajar
Cemerlang

IMPLEMENTASI BUDAYA ORGANISASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT

Mila Triana Sari
Daryanto
Miko Eka Putri



IMPLEMENTASI BUDAYA ORGANISASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT

Penulis:

Ns. Mila Triana Sari, M.Kep.

Daryanto, SKP., M.Kep.

Ns. Miko Eka Putri, M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Implementasi Budaya Organisasi dalam Peningkatan Kinerja Perawat di Rumah Sakit

Penulis: Ns. Mila Triana Sari, M.Kep.
Daryanto, SKP., M.Kep.
Ns. Miko Eka Putri, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-85-9

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, buku yang berjudul **"Implementasi Budaya Organisasi dalam Peningkatan Kinerja Perawat di Rumah Sakit"** ini dapat terwujud. Buku ini hadir sebagai bentuk komitmen dan upaya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam konteks peningkatan kinerja perawat di rumah sakit melalui pendekatan budaya organisasi yang efektif.

Peningkatan kinerja perawat merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu faktor penentu yang dapat mendorong peningkatan kinerja ini adalah budaya organisasi yang ada di rumah sakit. Melalui budaya organisasi yang sehat, seperti nilai-nilai saling menghargai, kerja sama tim yang solid, serta komitmen terhadap profesionalisme, diharapkan perawat dapat bekerja lebih efektif dan efisien, dengan semangat yang lebih tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Buku ini mengulas berbagai konsep dan pendekatan yang relevan dalam implementasi budaya organisasi di rumah sakit, serta memberikan panduan praktis mengenai bagaimana budaya tersebut dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan kinerja perawat. Berbagai teori

dan hasil penelitian yang terkait dengan budaya organisasi, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia juga dibahas dalam buku ini, sehingga pembaca dapat memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai topik ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi rumah sakit yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, humanis, dan berkinerja tinggi. Kami berharap, dengan implementasi budaya organisasi yang tepat, kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat semakin ditingkatkan dan memberikan dampak positif bagi pasien serta masyarakat secara keseluruhan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, baik dalam bentuk saran, kritik, maupun bantuan material yang sangat berharga. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang berguna dalam mewujudkan rumah sakit yang lebih baik dan profesional.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 BUDAYA ORGANISASI DAN IMPELEMENTASINYA PADA PERAWAT RUMAH SAKIT.....	7
---	----------

A. Budaya Organisasi.....	7
B. Jenis Budaya Organisasi	14
C. Dimensi dalam Budaya Organisasi.....	15
D. Peran dan Fungsi Budaya Organisasi	16
E. Fungsi Budaya Organisasi.....	19
F. Proses Sosialisasi Budaya Organisasi	25
G. Kekuatan dan Kelemahan Budaya Organisasi	27
H. Manfaat Budaya Organisasi.....	28
I. Ciri-Ciri dari Budaya Organisasi.....	29
J. Konsep Budaya Organisasi di Rumah Sakit	31
K. Budaya Organisasi dalam Pelayanan Keperawatan	34
L. Pengukuran Budaya Organisasi Dalam Keperawatan	34

BAB 3 KEPEMIMPINAN PERAWAT	49
---	-----------

A. Kepemimpinan Perawat	49
B. Gaya Kepemimpinan	51

BAB 4 KINERJA KEPERAWATAN.....	53
---------------------------------------	-----------

A. Pengertian Kinerja Keperawatan.....	53
B. Faktor Yang Mempengaruhi dengan Kinerja	54

C. Penilaian Kinerja	59
D. Tujuan Penilaian Kinerja	62
E. Standar Penilaian Kinerja	63

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	71
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	75
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Budaya organisasi dan kepemimpinan merupakan dua aspek penting yang mempengaruhi efektivitas operasional di rumah sakit, terutama dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan perawat. Kedua aspek ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kualitas perawatan pasien, meningkatkan kepuasan kerja perawat, serta mendorong terciptanya kerja sama tim yang lebih baik di rumah sakit.

Kinerja yang optimal dalam organisasi dapat diukur dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Darmojo et al. (2016), kinerja merupakan hasil kerja atau perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kepuasan kerja sangat penting dijaga oleh setiap organisasi, termasuk setiap rumah sakit. Sikap perawat atas pekerjaannya atau kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Temuan riset yang dilakukan oleh Luthans (2012), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh

langsung dari kepuasan kerja terhadap kinerja, kepuasan kerja yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kinerja.

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki beban cukup banyak dalam bekerja. Perawat memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan perawat yang tidak memiliki kepuasan dalam pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki arti penting bagi perawat maupun organisasi, khususnya demi terciptanya keadaan positif di lingkungan kerja. Perawat yang merasa puas akan pekerjaannya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk membicarakan hal-hal positif tentang organisasinya, membantu yang lain, dan berbuat kinerja pekerjaan mereka melampaui perkiraan normal. Faktor lain yang menentukan kinerja perawat adalah kepemimpinan. Bangun (2014), kinerja yang baik akan dapat berjalan ketika adanya kepemimpinan yang baik pula. Kartini (2016), kepemimpinan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja karena kepemimpinan dalam keperawatan merupakan bagian dari sistem manajemen keperawatan, dimana bagian dari sistem manajemen keperawatan mencakup pengumpulan data, perencanaan, pengaturan, kepegawaian, kepemimpinan dan pengawasan.

Komponen pengembangan manajemen kinerja perawat, terdiri dari standar pelayanan, uraian tugas, indikator kerja perawat, monitoring serta evaluasi. Dari kepuasan kerja dan kepemimpinan faktor yang menentukan peningkatan kinerja perawat adalah budaya organisasi. Aluko et al. (2014); Hollenbeck (2010), mengatakan bahwa faktor keberhasilan kinerja salah satunya adalah dengan menjaga budaya organisasi karena aplikasi dari budaya organisasi dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk meningkatkan produktivitas kerjanya serta produktivitas karyawan akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya di rumah sakit secara keseluruhan dan lebih jauh lagi dapat memberi dampak pada kelangsungan hidup rumah sakit di masa yang akan datang.

Budaya yang diajarkan sebenarnya pada aspek permukaan yang tampak saja (artefak), hal ini asumsi dasar sebagai inti dari budaya tidak akan terungkap dalam aturan perilaku yang diajarkan karena asumsi dasar merupakan aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak tampak di permukaan. Menurut Taraporevala & Sahin (2017), sosialisasi dapat dikonsepsikan sebagai proses yang terdiri atas tiga tahap yaitu kedatangan, keterlibatan (encounter) dan metamorfosis. Tahap pertama mengarah pada semua pembelajaran yang dilakukan sebelum karyawan baru bergabung dengan organisasi. Tahap

kedua, karyawan baru berusaha mencari seperti apa organisasi tersebut dan membandingkan keadaan yang diharapkan dengan realita yang mungkin saja berbeda. Tahap ketiga, muncul dan berlaku perubahan yang relatif bertahan lama.

Proses dengan ketiga tahap ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan komitmen karyawan baru terhadap tujuan organisasi dan keputusan mereka untuk bergabung dengan organisasi. Peningkatan pelayanan keperawatan dapat diupayakan dengan meningkatkan kinerja perawat yaitu dengan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan keperawatan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan keperawatan sangat mutlak diperlukan. Penataan lingkungan kerja yang kondusif perlu diciptakan agar perawat dapat bekerja secara efektif dan efisien (Masna, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Reydonnyzar dan Dadang Suwanda (2019), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial kepemimpinan dan budaya organisasi, memberikan pengaruh terhadap kinerja. Sejalan dengan yang dilakukan oleh Deutsch Perfekt (2016); Wulandari (2018), menunjukkan bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan penambahan variabel budaya organisasi sebagai variabel

dependen. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyanto & Ratri (2021), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi merupakan faktor penentu kepuasan karyawan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulekale (2016), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Taraporevala & Sahin (2017), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Terdapat perbedaan penelitian dari penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel kepuasan kerja sebagai variabel perantara (mediasi) antara kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja. Hal ini karena kepuasan karyawan terhadap kepemimpinan dan budaya organisasi akan mempengaruhi perilaku mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Perilaku ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja dan kinerja dari karyawan dan organisasi.

BAB 2

BUDAYA ORGANISASI DAN IMPELEMENTASINYA PADA PERAWAT RUMAH SAKIT

A. Budaya Organisasi

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi dan akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah hasil kerja dari sejumlah akal dan bukan hanya dari satu akal individu saja. Dalam bahasa inggris, kebudayaan berasal dari kata *culture*, yang berasal dari kata latin *colere*, yaitu mengelola dan mengerjakan. Menurut Muljono budaya adalah sebagai semua pola suasana baik material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai pemecahan masalah anggotanya, budaya di dalamnya juga termasuk semua cara yang telah terorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya yang implisit serta presmis yang mendasar dan mengandung suatu perintah. (Nawawi, 2015) Budaya adalah pola perilaku yang mengatur cara perawat berinteraksi dengan orang lain. Hal Ini

membantu dalam membedakan satu perawat dari yang lain (Kamel et al., 2017)

Peran budaya organisasi yang sangat penting dalam mempengaruhi setiap anggota organisasi saat menjalankan aktifitas serta dapat dibedakan melalui sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi tersebut (Robbins, 2016). Salah satu variabel penting yang dapat diuraikan sebagai dasar untuk aktifitas bagi budaya organisasi adalah sebagai berikut:

Budaya organisasi adalah merupakan kumpulan dari seperangkat sikap, nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dikembangkan dan dikomunikasikan dari generasi ke generasi berikutnya untuk membina hubungan dan mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal (Krietner & Kinicki, 2015; Mangukunegara, 2015; Schien, 1992 dalam Wirawan, 2017). Selanjutnya Krietner & Kinicki (2015) menjelaskan bahwa budaya organisasi juga dapat dirasakan, dipikirkan dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Organisasi- organisasi juga dapat dibedakan melalui sistem nilai-nilai yang dianut oleh anggota organisasi itu sendiri (Robbins, 2016). Sedangkan Rivai (2017), mendefenisikan pengertian budaya organisasi sebagai suatu pola asumsi dasar yang dimiliki bersama dan

didapat oleh kelompok ketika akan memecahkan masalah penyesuaian eksternal dan integrasi internal.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, disimpulkan bahwa pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, keyakinan, asumsi dasar, yang dianut serta diwariskan kepada anggota organisasi dan merupakan norma-norma pedoman perilaku yang dapat mengatur kehidupan anggota organisasi, dalam beradaptasi baik terhadap lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah sekumpulan nilai-nilai yang mendasari seorang perawat dalam berperilaku di dalam suatu kelompok organisasi. Ndraha dalam (Timotius, 2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi budaya, yang terdiri dari:

1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat.
2. Sebagai suatu pengikat masyarakat.
3. Sebagai sumber, budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya.
4. Sebagai kekuatan penggerak dan pengubah.
5. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah.
6. Sebagai pola perilaku.
7. Sebagai warisan, budaya disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya.

8. Sebagai substitusi (pengganti) formalisasi, sehingga tanpa diperintahkan orang melakukan tugasnya.
9. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan.
10. Sebagai proses yang mempersatukan.
11. Sebagai produk proses usaha mencapai tujuan bersama dan sejarah yang sama.
12. Sebagai program mental sebuah masyarakat.

Selanjutnya adalah kata organisasi, Organisasi mencirikan forum di mana individu dengan berbagai latar belakang, kemampuan, kepribadian dan perilaku wok bersama-sama sebagai unit koperasi untuk mencapai tujuan tertentu (Kamel et al., 2017) Organisasi merupakan sarana bagi kerjasama yang efektif dan efisien. Orang yang bekerja di dalam organisasi dapat menjadi lebih produktif dan efisien dari pada orang yang bekerja sendirian. Produksi barang-barang dan jasa akan lebih banyak diciptakan daripada bekerja secara individual. Hal ini membuktikan bahwa, bekerja dalam organisasi secara tim dapat meningkatkan kuantitas barang maupun jasa (Silalahi, 2011).

Organisasi adalah satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa orang yang memiliki sedikit atau banyaknya kesamaan latar belakang, identitas, harapan, dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penerapannya, seseorang yang berada di dalam organisasi bekerja berdasarkan tugas masing-

masing, dan saling berkoordinasi dengan satu sama lain tanpa mengintervensi, dan tumpang tindih kewajiban dengan orang lain.(Timotius, 2016) Ciri-ciri umum sebuah organisasi sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, jumlah terbanyak tak terbatas.
2. Setiap individu memiliki tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
3. Memiliki struktur organisasi yang menguraikan posisi dan pembagian kerja.
4. Terdapat kantor kerja/ruang/lokasi/sekretariat untuk beraktivitas, dan mengadakan pertemuan membahas kegiatan organisasi.
5. Cakupan wilayah kegiatan operasional organisasi jelas.
6. Organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Bila nilai-nilai pokok organisasi dapat dipahami secara jelas dan diterima secara luas, para karyawan akan mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang diharapkan dari diri mereka, sehingga mereka selalu dapat bertindak dengan cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan secara profesional.

Budaya Organisasi yaitu Budaya yang terbentuk dalam sebuah organisasi yang menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Menurut G. Graham dalam Siswadi (2012) budaya organisasi adalah norma, keyakinan, sikap dan filosofi organisasi. Menurut Robbins dalam

Sembiring (2012) budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lainnya. (Iqbal et al., 2017) Budaya organisasi membentuk perilaku seseorang dalam bertindak. Ada beberapa komponen dalam pembentukan budaya organisasi;

1. Menciptakan pernyataan nilai dan kepercayaan.
2. mempraktikkan komunikasi yang efektif.
3. Mereview struktur organisasi.
4. Desain ulang pendekatan terhadap *reward* dan *punishment*.
5. Review semua sistem kerja.

Menurut (Robbins & Stephen, 2010) para karyawan belajar tentang budaya organisasi melalui berbagai cara, diantaranya melalui cerita, acara-acara simbolik (ritual), simbol-simbol keberadaan, dan bahasa yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Cerita. Dalam organisasi biasanya terdapat berbagai kenangan dari berbagai kejadian atau orang-orang penting, termasuk kisah pendirian organisasi, pelanggaran atas peraturan.
2. Acara-acara simbolis (ritual). Apabila seorang karyawan menerima tugas yang cukup berat dan telah menyelesaikannya maka akan menerima penghargaan, sebagai tanda bahwa terdapat

- dukungan penuh kepada sang karyawan. Agar dapat membangkitkan motivasi dan harapan dalam diri karyawan dalam melakukan tugasnya dengan baik.
3. Simbol-simbol kebendaan. Tata letak kantor atau ruangan milik organisasi, dan cara berpakaian karyawan merupakan salah satu nuansa kepribadian organisasi.
 4. Bahasa. Banyak organisasi yang menggunakan bahasa sebagai cara mengasosiasikan serta menyatukan para anggotanya ke dalam sebuah budaya. Dengan mempelajari bahasa, para anggota organisasi mengakui penerimaan mereka terhadap budaya organisasi dan kesediaannya untuk membantu mempertahankannya.

Semua organisasi memiliki budaya, namun tidak semua organisasi sama kuatnya dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan para karyawan (Robbins, 2010). Sathe dalam Ndraha mengungkapkan budaya kuat adalah budaya organisasi yang ideal, dianut secara luas dan jelas penyampainnya serta kekuatan budaya mempengaruhi intensitas perilaku. Hal ini senada dengan pendapat Robbins dalam Ndraha, yang mengatakan budaya kuat adalah budaya organisasi yang dipegang semakin intensif (nilainya tertanam semakin mendasar dan kokoh), semakin luas dianut (semakin banyak warga organisasi yang menganutnya),

dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat budaya, semakin kuat efek atau pengaruhnya terhadap lingkungan dan perilaku manusia. (Apriyatmoko & Susilo, 2014)

B. Jenis Budaya Organisasi

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam (Arianty, 2014) bahwa secara umum terdapat tiga (3) jenis budaya organisasi yaitu:

1. Budaya konstruktif Budaya konstruktif adalah budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyeknya dengan cara yang membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi dan persatuan.
2. Budaya pasif-defensif Budaya pasif-defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghidupan.

3. Budaya agresif defensif Budaya agresif–defensif mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif dan perfeksionis.

C. Dimensi dalam Budaya Organisasi

Menurut Robbins (2010) ada tujuh dimensi yang menjabarkan budaya sebuah organisasi. Masing-masing dari ketujuh dimensi tersebut memiliki kisaran mulai dari rendah hingga tinggi, yang artinya sebagai “hal yang sangat tidak lumrah dalam organisasi” (rendah) atau “hal yang sangat lumrah dalam organisasi” (tinggi). Menjabarkan sebuah organisasi dengan menggunakan ketujuh dimensi ini dapat menampilkan gambaran komposit menyangkut budaya organisasi dalam organisasi tersebut. (Hilda, 2018) Adapun tujuh dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi dan pengambilan risiko adalah seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko.
2. Perhatian pada detail adalah seberapa dalam ketelitian, analisis dan perhatian pada detail yang dituntut oleh organisasi dari para karyawannya.

3. Orientasi hasil adalah seberapa besar organisasi menekankan pada pencapaian sasaran (hasil), ketimbang pada cara mencapai sasaran (proses).
4. Orientasi manusia adalah seberapa jauh organisasi bersedia mempertimbangkan faktor manusia (karyawan) didalam pengambilan keputusan manajemen.
5. Orientasi tim adalah seberapa besar organisasi menekankan pada kerja kelompok (tim), ketimbang kerja individu, dalam menyelesaikan tugas-tugas.
6. Agresivitas adalah seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk saling bersaing, ketimbang saling bekerjasama.
7. Stabilitas adalah seberapa besar organisasi menekankan pada pemeliharaan status quo di dalam pengambilan berbagai keputusan dan tindakan.

D. Peran dan Fungsi Budaya Organisasi

Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi budaya organisasi juga dapat menghambat perkembangan organisasi. Berikut ini dikemukakan peran budaya organisasi terhadap organisasi, anggota organisasi, dan mereka yang berhubungan dengan organisasi:

1. Identitas organisasi. Budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi menunjukkan identitas organisasi kepada orang di luar organisasi.
2. Menyatukan organisasi. Budaya organisasi merupakan lem normative yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma, nilai-nilai, dan kode etik budaya organisasi menyatukan dan mengkoordinasi anggota organisasi. Ketika akan masuk menjadi anggota organisasi, para calon anggota organisasi mempunyai latar belakang budaya dan karakteristik yang berbeda. Agar dapat diterima sebagai anggota organisasi, mereka wajib menerima dan menerapkan budaya organisasi.
3. Reduksi konflik. Budaya organisasi sering dilukiskan sebagai semen atau lem yang menyatukan organisasi. Isi budaya mengembangkan kohesi sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang berbeda, pola pikir, asumsi, dan filsafat organisasi yang sama memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik diantara anggota organisasi.
4. Komitmen kepada anggota organisasi dan kelompok. Budaya organisasi bukan saja menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok

kerjanya. Budaya organisasi yang kondusif mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya.

5. Reduksi ketidakpastian. Budaya organisasi mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepastian. Dalam mencapai tujuannya, organisasi menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan, demikian juga aktivitas anggota organisasi dalam mencapai tujuan tersebut.
6. Menciptakan konsistensi. Budaya organisasi menciptakan konsistensi berpikir, berperilaku, dan merespon lingkungan organisasi. Budaya organisasi memberikan peraturan, panduan, prosedur, serta pola memproduksi dan melayani konsumen, nasabah, pelanggan, atau klien organisasi.
7. Motivasi. Budaya organisasi merupakan kekuatan tidak terlihat di belakang faktor-faktor organisasi yang kelihatan dan dapat diobservasi. Budaya merupakan energi sosial yang membuat anggota organisasi untuk bertindak. Budaya organisasi memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan motivasi

kerja karyawan. Semua faktor tersebut merupakan indikator terciptanya kinerja tinggi dari karyawan yang akan menghasilkan kinerja organisasi yang juga tinggi.

9. Keselamatan kerja. Budaya organisasi mempengaruhi keselamatan kerja. Richard L Gardner menemukan ada hubungan kausal positif antara budaya organisasi dan kecelakaan industri. Untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kerja.
10. Sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi yang kuat mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan.

E. Fungsi Budaya Organisasi

Menurut (Kreitner & Kinicki, 2005) budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas perusahaan. Adapun fungsi budaya organisasi antara lain:

1. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, sebagai perusahaan yang inovatif yang memburu pengembangan produk baru.
2. Memudahkan komitmen kolektif, sebuah perusahaan di mana karyawannya bangga menjadi bagian

darinya atau cenderung tetap bekerja dalam waktu lama.

3. Mempromosikan stabilitas sistem sosial, mencerminkan taraf di mana lingkungan kerja dirasakan positif dan mendukung, konflik dan perubahan diatur dengan efektif.
4. Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya, di mana membantu karyawan memahami mengapa organisasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana perusahaan bermaksud mencapai tujuan jangka panjangnya.

Fungsi budaya organisasi adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, serta melakukan integrasi internal. Ada lima fungsi budaya organisasi (Robbins, 2016; Rivai, 2017), yaitu:

1. Berperan menetapkan tapal batas,
2. Memberi rasa identitas ke anggota-anggota organisasi.
3. Mempermudah komitmen yang lebih luas dari pada kepentingan diri pribadi seseorang.
4. Meningkatkan kemantapan sistem sosial dengan memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan.

5. Sebagai mekanisme pembuat makna/nilai dan mekanisme pengendalian sikap dan perilaku karyawan.

Menurut Tika (2016), fungsi dari budaya organisasi adalah:

1. Batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok yang lain,
2. Perekat bagi para karyawan dalam suatu organisasi,
3. Stabilitas dalam sistem sosial,
4. Mekanisme kontrol dalam memadu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan,
5. Integrator,
6. Membentuk perilaku para karyawan,
7. Sarana penyelesaian masalah-masalah pokok organisasi,
8. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan perusahaan,
9. Sebagai alat komunikasi,
10. Sebagai faktor penghambat dalam berinovasi, bila budaya tidak mampu mengatasi masalah yang menyangkut lingkungan eksternal dan integrasi internal.

Kreitner dan Kinicki (2013), fungsi budaya organisasi dibagi menjadi empat, yaitu:

1. memberikan identitas organisasi kepada para karyawannya,

2. memudahkan komitmen kolektif,
3. terpromosikannya stabilitas sistem sosial
4. dapat membentuk perilaku manajer untuk merasakan keberadaannya.

Tabel 2.1 Fungsi – Fungsi Organisasi (Shein, 1992)

No	Adaptasi Eksternal	Integrasi Internal
1	Misi dan Strategi: dihasilkannya suatu pengertian bersama tentang misi utama, tugas pokok, fungsi, yang tampak dan tersembunyi.	Bahasa bersama dan kategori konsep: Bila ada karyawan yang tidak dapat berkomunikasi dan bisa saling memahami satu sama lain, pada suatu kelompok sulit untuk didefinisikan.
2	Tujuan: dikembangkannya konsensus tentang tujuan yang dijabarkan dari misi utama.	Batas dan kriteria kelompok yaitu merupakan suatu bidang terpenting dari budaya adalah konsensus bersama tentang kriteria untuk menentukan keanggotaan.
3	Cara: dikembangkannya konsensus tentang apa cara yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan seperti struktur organisasi, pembagian	Kekuasaan dan status: organisasi harus bekerja dengan susunan kekuasaan, kriteria dan aturan tentang bagaimana karyawan mendapatkan, memelihara dan kehilangan kekuasaan, konsensus dalam bidang ini sangat penting untuk

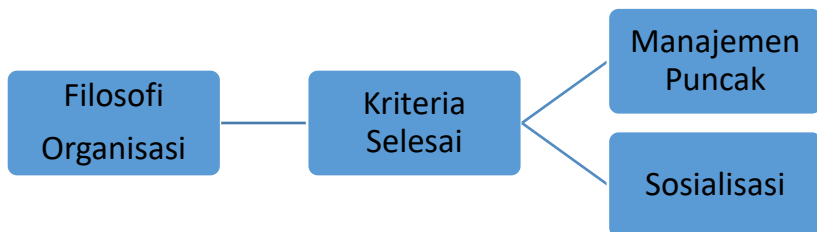
	tugas dan sistem kewenangan.	membantu karyawan dalam mengendalikan perasaan agresi.
--	------------------------------	--

Sumber : Diadaptasi dari Edgar H Schein (1992) dalam Siswadi (2012) *Organizational Culture and Leadership* Ossey-Bass Publisher, San Francisco, pp 52 and 66

Didasarkan dari fungsi budaya organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya dapat bernilai untuk organisasi dan karyawan, dapat meningkatkan komitmen dalam organisasi dan adanya konsistensi terhadap perilaku karyawan.

Pembentukan Budaya Organisasi

Skema pembentukan budaya organisasi dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Pembentukan Budaya Organisasi

Sumber: Robins (2016)

Budaya organisasi dibentuk dengan diawali oleh falsafah dasar pemilik organisasi yang merupakan budaya asli organisasi, yang mempunyai pengaruh sangat kuat dalam memilih kriteria yang tepat. Selanjutnya falsafah dasar organisasi diturunkan kepada manajer puncak yang bertugas menciptakan suatu iklim organisasi yang kondusif agar dapat diterima oleh seluruh anggota, berupa nilai-nilai peraturan, kebiasaan-kebiasaan agar dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Tahap selanjutnya adalah proses sosialisasi, dengan sosialisasi yang tepat akan terbentuk budaya organisasi yang diharapkan.

F. Proses Sosialisasi Budaya Organisasi

Proses sosialisasi pada pembentukan budaya organisasi yaitu proses penyesuaian karyawan terhadap nilai-nilai yang ada. Ada tiga tahap dalam proses sosialisasi menurut Robbins (2016) yaitu :

1. Tahap Pra kedatangan;

Terjadi sebelum kedatangan anggota baru. Setiap individu tiba dengan seperangkat nilai, sikap, dan harapan tentang pekerjaan dan kondisi organisasi.

2. Tahap Keterlibatan;

Terjadi ketika anggota baru sudah memasuki sebuah organisasi, kemudian anggota baru itu melihat seperti apa organisasi tersebut, pada saat ini akan terjadi perbedaan antara harapannya mengenai pekerjaan, rekan sekerja, atasan, dan organisasi dan kenyataan. Ketika harapan dan kenyataan berbeda, pegawai baru itu harus menjalani sosialisasi dan melepas harapan-harapan sebelumnya dan menggantikan dengan hal yang lebih sesuai dengan organisasi tersebut. Namun jika hal tersebut tidak dapat dilakukan dan pegawai baru merasa dikecewakan, selanjutnya maka ia akan mengundurkan diri.

3. Tahap Metamorfosis;

Pegawai baru berhasil melakukan penyesuaian terhadap nilai dan norma yang ada dalam kelompoknya dan dapat berperan sesuai dengan pekerjaannya, serta menimbulkan rasa nyaman dalam organisasi itu.

Schein (1992, dalam Rivai, 2017) mengemukakan ditemukannya tiga tingkatan dalam budaya organisasi, yaitu:

1. *Artefact,*

Yaitu merupakan budaya organisasi tingkat pertama dimana budaya bersifat kasat mata tetapi seringkali tidak dapat diartikan, misalnya lingkungan fisik organisasi, teknologi, cara berpakaian, termasuk produk, jasa, dan bahkan pola perilaku kelompok.

2. *Espoused values,*

Yang merupakan tingkatan budaya organisasi ke dua, dimana nilai-nilai yang dipegang oleh anggota organisasi sehingga ia mendukung dan mau berkorban untuk organisasi.

3. *Basic Assumption,*

Merupakan tingkatan ke tiga yang juga merupakan bagian terpenting dari budaya organisasi, dimana sudah ada keyakinan yang dipercaya oleh anggota organisasi, karena asumsi menunjukkan apa yang dipercaya oleh anggota

sebagai kenyataan dan karenanya mempengaruhi apa yang mereka pahami, pikirkan dan rasakan.

G. Kekuatan dan Kelemahan Budaya Organisasi

Berdasarkan pelaksanaannya budaya organisasi dapat dibedakan atas budaya organisasi yang kuat dan budaya organisasi yang lemah. Tika (2016) budaya organisasi yang kuat didefinisikan sebagai budaya yang mengandung nilai-nilai secara formal maupun informal baik, dianut secara bersama dan mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja pimpinan dan anggota organisasi sehingga organisasi akan kuat dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal. Nilai-nilai budaya juga dapat diterjemahkan sebagai filosofi, asumsi dasar, slogan, moto, tujuan atau prinsip yang menjelaskan usaha yang bila dianut dan dilaksanakan bersama akan dapat memperkuat budaya organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang lemah didefinisikan sebagai budaya organisasi yang kurang didukung secara luas oleh para anggotanya sehingga dapat berpengaruh negatif pada anggotanya. Menurut Luthans (2016) dijelaskan faktor-faktor utama yang dapat menentukan kekuatan budaya organisasi adalah kebersamaan dan intensitas. Kebersamaan adalah sejauh mana anggota organisasi mempunyai nilai-nilai dasar yang dianut bersama dan

dipengaruhi oleh unsur orientasi dan imbalan. Sedangkan intensitas adalah derajat komitmen dari anggota organisasi kepada nilai-nilai inti dalam budaya organisasi. Apabila kedua faktor tersebut kurang maka akan menunjukkan kelemahan dari suatu budaya organisasi.

H. Manfaat Budaya Organisasi

Menurut Sutrisno (2011:27), beberapa manfaat budaya organisasi adalah sebagai berikut :

1. Membatasi peran yang membedakan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada dalam organisasi.
2. Menimbulkan rasa memiliki sebagai identitas para anggota organisasi. Dengan budaya organisasi yang kuat anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasi.
3. Mementingkan tujuan bersama dari pada mengutamakan kepentingan individu.
4. Menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif stabil.

Keempat manfaat tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat membentuk perilaku dan tindakan karyawan dalam menjalani aktivitasnya di dalam organisasi, sehingga nilai-nilai yang ada dalam budaya organisasi perlu ditanamkan sejak dini pada setiap individu organisasi.

I. Ciri-Ciri dari Budaya Organisasi

Adapun ciri- ciri Budaya Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Ciri-ciri Budaya Organisasi yang Kuat.

Deal dan Kenedy (1982, dalam Tika, 2016) dikemukakannya bahwa budaya organisasi yang kuat adalah memiliki ciri-ciri anggota organisasi sangat loyal, tahu dengan jelas apa tujuan dari organisasi, pedoman bertingkah laku pada anggota organisasi sudah digariskan dengan jelas, Pandangan yang baik atau pandangan yang tidak baik, dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan sehingga ada kesamaan diantara anggota organisasi; nilai-nilai tidak hanya sebagai slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh seluruh anggota organisasi; organisasi ini memberi tempat khusus kepada pahlawan- pahlawan perusahaan seperti diberikannya penghargaan kepada karyawan berprestasi; organisasi yang mempunyai ritual dari

yang sederhana hingga yang mewah, di mana sang pimpinan dapat meluangkan waktu untuk ikut dalam ritual tersebut; serta memiliki jaringan kultural yang menampung cerita kehebatan dari para pahlawannya.

Robbins (2016) juga mengemukakan ciri-ciri budaya yang kuat itu antara lain: menurunnya tingkat keluar (*turn over*) karyawan; ada kesepakatan yang tinggi di kalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan dalam organisasi; ada pembinaan yang kohesif, kesetiaan dan komitmen organisasi. Hal ini juga sama dengan pendapat Sembiring (2012) yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang kuat itu memiliki ciri kekentalan budaya yang dianut secara luas dan jelas dalam penyampaian.

2. Ciri-ciri budaya organisasi yang lemah.

Deal dan Kennedy (1982, dalam Tika, 2016) mengungkapkan bahwa ciri-ciri budaya organisasi yang lemah adalah: mudahnya terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain; adanya kesetiaan kepada kelompok yang melebihi kesetiaan kepada organisasi, anggota organisasi yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri.

J. Konsep Budaya Organisasi di Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Dengan, 2015). (Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, 2006) Rumah sakit memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian layanan kesehatan.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang memiliki nilai-nilai tertentu, dalam mencapai tujuan rumah sakit memberikan pelayanan yang berkualitas

salah satunya ditentukan oleh kinerja perawat (Andriani 2012). Menurut Robbins (2010), nilai-nilai, prinsip, tradisi dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak disebut sebagai budaya organisasi. (Hilda, 2018).

Karakteristik Kebudayaan Rumah Sakit (Organisasi) di mana asumsi karyawan tentang keterkaitan lingkungan organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi mereka didominasi dan sangat dipengaruhi oleh beberapa pihak eksternal, yaitu pemilik saham, Departemen Kesehatan sebagai pembina teknis, dan masyarakat pengguna jasa kesehatan sebagai konsumen. Peran masyarakat kini begitu dirasakan sejak RS menjadi institusi yang harus mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa mengandalkan subsidi lagi. Pada situasi seperti ini, karyawan menyadari betul fungsi yang harus dimainkan ketika berhadapan dengan konsumen, yaitu mereka harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan keluarganya, serta para pengunjung lainnya.

Semakin ketat persaingan pelayanan rumah sakit dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan membuat keinginan rumah sakit untuk berlomba-lomba meningkatkan mutu pelayanan yang berfungsi untuk menarik pelanggan. Persaingan ini

didasari oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam kesehatan, dimana dari data (World Health Organization) WHO tahun 2006, Indonesia merupakan salah satu ke sekian dari 57 negara yang menghadapi krisis sumber daya manusia tenaga kesehatan, jumlah yang kurang dari distribusinya. Tingkat keberhasilan rumah sakit sangat bergantung pada budaya organisasi, kemudahan, kecepatan, efektifitas pelayanan keamanan dan keyamanan budaya organisasi (Kemenkes RI, 2010). Budaya organisasi selalu diharapkan baik akan ada hubungan dengan sukses tidaknya organisasi tersebut. Budaya organisasi rumah sakit yang positif akan membuat organisasi tersebut menjadi lebih baik.

Menurut Napirah, Herwanto & Magido (2016) Budaya organisasi rumah sakit yang berkualitas baik tidak lepas dari nilai-nilai yang diterapkan oleh perawat itu sendiri contoh keadilan, nilai altruistik, nilai menghargai, kebenaran, nilai persamaan dan martabat manusia, yang mendukung perawat sehingga menjadi budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi yang mempunyai kelebihan dan juga masih mempunyai kekurangan disebabkan karena masih ada nilai-nilai organisasi yang dipercaya perawat.

K. Budaya Organisasi dalam Pelayanan Keperawatan

Konsep dalam budaya organisasi pada pelayanan keperawatan yang merupakan sebagai bagian dari organisasi rumah sakit merupakan hal yang sangat penting. Muchlas (2015) mengemukakan bahwa budaya organisasi rumah sakit merupakan pedoman atau acuan untuk mengendalikan perilaku organisasi dan perilaku perawat dan tenaga kesehatan lain dalam berinteraksi di antara mereka dan dalam berinteraksi dengan rumah sakit lain.

Dari berbagai macam tim kesehatan yang ada keberadaan perawat merupakan bagian yang cukup besar di dalam organisasi rumah sakit, oleh karena itu penciptaan nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman bekerja bagi semua anggota rumah sakit seharusnya dapat diwarnai oleh peran-peran keperawatan. Selain itu juga adanya kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan profesional sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi di mana perawat itu bekerja, yang mana ada nilai-nilai yang berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain.

L. Pengukuran Budaya Organisasi Dalam Keperawatan

1. Competing Values Framework

Cameron dan Quinn membuat sebuah metode

untuk mengenali tipe-tipe budaya dalam organisasi yang disebut dengan *Competing Values Framework*. Model *Competing Value Framework* ini berguna dalam membantu menginterpretasikan fenomena organisasi yang bermacam-macam jenisnya.

2. Indikator Pengukuran Budaya Organisasi

Dalam riset mereka mengenai efektifitas organisasi, ternyata 39 indikator efektifitas organisasi dari hasil penelitian Jhon Campbell dan rekan-rekannya (Cameroon & Quinn, 2011) dapat diajukan sebagai suatu analisa terdiri dari dua dimensi utama yang mengatur indikator – indikator tersebut menjadi empat kluster utama yaitu:

- a. *Clan Culture* Model atau jenis budaya yang lebih menitikberatkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan (*clan*) yang sifatnya dan ciri-ciri kekeluargaan inilah sangat menonjol. Gaya kepemimpinan yang berkembang biasanya lebih cenderung sebagai yang memfasilitasi (fasilitator) konflik atau segenap permasalahan yang berkembang dalam organisasi. Kriteria efektivitas ditekankan pada kohesivitas kelompok (*team*), pengembangan moral karyawan (*employee moral*) serta sumberdaya manusia (SDM).
- b. *Adhocracy Culture* Model atau jenis budaya ini cenderung bersifat “mengalir” dalam artian

anggota organisasi tidak dibatasi oleh struktur, sebab model ini lebih mementingkan penciptaan situasi dimana karyawan bisa dengan bebas menggali serta menyalurkan ide-ide segar, kreatif, dan inovatif dikembangkan lebih sebagai innovator, wirausaha, serta *visionary leadership*. *Effectiveness* (kriteria efektivitas) dititik beratkan pada output yang jelas, proses kerja yang efektif serta prinsip pertumbuhan.

- c. *Hierarchy Culture* Budaya ini sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan rapi dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis. Birokrasi sangat relevan dengan jenis budaya ini. Gaya kepemimpinan yang dikembangkan adalah sebagai kordinator dengan fungsi mentoringnya yang kuat dan ketat, sekaligus juga sebagai organisator yang unggul. Kriteria efektivitas ditekankan pada efisiensi serta batasan-batasan waktu yang tegas dan ketat.
- d. *Market Culture* Jenis budaya yang mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi. Bahkan bagi organisasi dengan *market culture* yang kuat. Situasi persaingan yang ketat dan tinggi bukan hanya ditunjukan bagi kompetitor bisnis saja, melainkan dikalangan karyawan. Gaya kepemimpinan yang

dikembangkan adalah sebagai competitor dan pendorong yang tangguh.

3. Instrumen Pengkajian Budaya Organisasi (*Organizational Cultural Assessment Instrument-OCAI*).

Nilai budaya dalam sebuah organisasi dapat diukur dengan menggunakan metode *Organizational Culture Assessment Instrument* (OCAI)^{4,6,11}. Konsep ini disebut dengan *Competing Values Framework*. OCAI ini tidak hanya memberikan penilaian budaya organisasi yang akurat, tetapi juga menilai efektivitas indikator dalam organisasi^{4,6,11}.

Berdasarkan kerangka *Competing Values Framework*, Cameron dan Quinn mengembangkan instrumen tersebut dengan survei secara kuantitatif yang disebut dengan *Organizational Culture Assesment Instrument* (OCAI). *Organizational Culture Assesment Instrument* (OCAI) sangat berguna dalam mencerminkan ke arah mana perusahaan ini dikelompokkan berdasarkan kulturnya seperti yang sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya yaitu budaya *clan*, *adhocracy*, *hierarchy*, atau *market* untuk mendukung misi dan tujuannya, dan juga untuk dapat mengidentifikasi elemen-elemen di dalam kultur yang dapat melawan misi dan tujuan. Hal ini juga bermanfaat, ketika

sebuah perusahaan sedang mencari kembali jati dirinya dan mendefinisikan ulang kebudayaan di dalamnya, sehingga dapat mencari elemen apa saja yang dapat mendukung kegiatan perusahaan. Tujuan OCAI adalah untuk menilai enam dimensi kunci budaya organisasi yang dikaitkan oleh 4 tipe budaya yang sudah dijelaskan, dimensi budaya tersebut:

- a. Karakteristik Dominan. Dimensi ini menunjukkan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Melalui penghitungan diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam lingkungan organisasi.
- b. Kepemimpinan Organisasi Dimensi ini menunjukkan gaya kepemimpinan apa yang ada di organisasi, model kepemimpinan, dan persepsi bawahan terhadap model kepemimpinan yang ada. Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam ranah kepemimpinan di organisasi tersebut.
- c. Pengelolaan Karyawan Dimensi ini menunjukkan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam pengelolaan karyawan.

- d. Perekat Organisasi Dimensi ini menunjukkan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam hal menjadi faktor perekat organisasi.
- e. Penekanan Strategis Dimensi ini menunjukkan bagaimana cara organisasi untuk memfokuskan segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang ada. Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam penekanan strategis.
- f. Kriteria Keberhasilan Dimensi ini menunjukkan bagaimana perusahaan menetapkan standar di dalam pencapaian tujuan yang ada. Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam kriteria sukses.

Penilaian ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi budaya suatu organisasi yang ada saat ini (*current culture*) dan membantu dalam mengidentifikasikan budaya yang harus dikembangkan dalam menghadapi tuntutan lingkungan yang akan datang dan berbagai hal mungkin akan dihadapi organisasi. Dengan instrumen ini dapat dikenali budaya yang dominan (*cultural strength*), tipe- tipe budaya yang ada

(*cultural type*), dan kesesuaian budaya tersebut (*cultural congruence*).

Pendekatan menggunakan instrument OCAI, mendiagnosa dan merubah budaya organisasi atau perusahaan terdapat 6 kelebihanannya yaitu:

- a. *Practical* Instrumen ini dapat mengidentifikasi dimensi kunci budaya yang ditemukan untuk menghasilkan perbedaan dalam kesuksesan organisasi.
- b. *Timely Proses* dari diagnosa dan penciptaan strategi untuk perubahan dapat disesuaikan dalam waktu yang cukup masuk akal.
- c. *Involving* Setiap langkah dalam proses ini melibatkan seluruh anggota organisasi, khususnya bagi mereka yang mempunyai tanggungjawab dalam mengembangkan aturan, penguatan nilai-nilai, dan mengembangkan pedoman perubahan yang fundamental.
- d. *Qualitative* Proses ini berdasarkan pada pengukuran kuantitatif dari dimensi kunci budaya dan metode kualitatif yang meliputi sejarah, peristiwa, dan simbolsimbol yang mewakili nilai-nilai yang tidak dapat terukur dalam organisasi.
- e. *Managible* Proses diagnosa dan perubahan dapat dilakukan dan diimplementasikan oleh tim dalam organisasi, biasanya tim manajemen. Diagnosa

dari luar ahli-ahli budaya, atau konsultan perubahan tidak diperlukan untuk kesuksesan dalam pengimplementasian.

- f. Valid Kerangka kerja dalam proses ini dibangun tidak hanya untuk dapat dimengerti orang-orang sebagai pemilik organisasi tetapi juga didukung dengan literatur empiris yang lengkap dan dimensi yang memiliki dasar ilmiah yang telah diverifikasi.

Instrumen ini berbentuk kuesioner yang memerlukan tanggapan dari responden cukup dengan memberikan enam pertanyaan berdasarkan enam dimensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Instrumen ini terbukti bermanfaat dan akurat dalam mendiagnosa aspek-aspek penting organisasi yang berkenaan dengan budaya.

4. Hasil Pengukuran Budaya Organisasi (*Organizational Cultural Assessment Instrument-OCAI*).

- a. Persepsi dan Harapan Perawat Mengenai Budaya Organisasi Saat ini. Budaya organisasi diukur menggunakan model *Organizational Culture Assessment Instrument* (OCAI) dengan indikator meliputi karakter dominan, kepemimpinan organisasi, pengelolaan pegawai, perekat organisasi, strategi yang diterapkan dan kriteria

keberhasilan yang dapat membentuk suatu budaya organisasi model OCAI yaitu budaya *Clan*, budaya *Adhocracy*, budaya *Market* dan budaya *Hirarki*. Kuesioner disebarakan kepada 96 Perawat di RS Jiwa Daerah Jambi.

Hasil yang didapatkan dari responden terhadap kuesioner model OCAI mengenai budaya organisasi saat ini dan budaya harapan dari persepsi perawat di RS Jiwa Daerah Jambi, Bahwa karakter budaya organisasi saat ini yang dominan peringkat pertama adalah Hierarchy, peringkat kedua, Market, peringkat ketiga Adhocracy dan Clan ke empat. Sedangkan karakter budaya yang diharapkan akan datang dominan di peringkat pertama adalah Clan, kedua Hierarchy, ketiga Adhocracy dan terakhir Market. Selanjutnya berdasarkan persepsi budaya saat ini dan yang akan datang digambarkan bahwa karakter budaya yang sudah sesuai dengan harapan adalah budaya Hierarchy dan Market sedangkan yang diharapkan kedepan adalah budaya Clan dan Hierarchy (Sari., Daryanto., Putri, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian lain dimana karakter budaya saat ini didominasi oleh Hierarchy di peringkat pertama dan Market di peringkat kedua; Berbeda halnya

dengan budaya organisasi di Bank swasta dimana budaya organisasi didominasi oleh budaya Clan dan Adhocracy. Budaya organisasi pada Pejabat Struktural RS saat ini juga didominasi dengan budaya *Hierarchy* dan budaya *Clan*.

Lebih lanjut budaya organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya hierarki (Amran dan Setyanegara, 2021). Hal ini menegaskan bahwa berdasarkan persepsi staf perawatan, budaya organisasi Hierarki dipersepsikan lebih dominan dalam aktifitas organisasi sehari-hari, demikian pula bagi pejabat rumah sakit. Budaya hirarki sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan konsisten dalam organisasi. Aktifitas pekerjaan diatur sesuai ketentuan dan sistematis. Pimpinan organisasi mengkoordinasikan setiap kegiatan disertai dengan mentoring yang kuat dan ketat serta menekankan efisiensi dengan batasan waktu yang tegas dan ketat. Oleh karena itu persepsi budaya organisasi yang berlaku di rumah sakit juga dipengaruhi bagaimana perilaku pemimpin dalam menerapkan nilai-nilai budaya pada organisasi tersebut akan turut mempengaruhi target kinerja yang diharapkan pemimpin tersebut.

Hasil penelitian ini dan beberapa penelitian

sebelumnya menegaskan bahwa penerapan budaya Clan agar bisa ditingkatkan dalam aktivitas organisasi. Penerapan budaya Clan sebenarnya mirip dengan pendekatan keluarga dimana budaya organisasi ini dikelola dengan semangat tim kerja dengan semangat belajar bersama, memberikan umpan balik atas kinerja dan mengkomunikasikan jika ada kekeliruan, sumberdaya manusia dikembangkan dan respons atas peristiwa yang terjadi pada staff tidak bersifat tidak menghukum.

b. Persepsi perawat terhadap budaya organisasi

Hasil Penelitian persepsi perawat pelaksana terkait budaya organisasi yang diukur berdasarkan aspek keterlibatan, Penyesuaian, Konsistensi, Misi serta persepsi budaya organisasi secara keseluruhan di RS (Sari, 2019). Secara komposit sebagian besar atau mayoritas perawat pelaksana di RSJ Jambi berpersepsi baik tentang budaya organisasinya (77.9%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kholifah (2013) dan RU Panjaitan (2014), yang menyampaikan hasil penelitiannya tentang persepsi budaya organisasi yang baik oleh perawat pelaksana di RSUD Ambarawa dan RS Bogor akan menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan organisasi dan tercermin pada

nilai-nilai yang diterapkan saat pemberian asuhan keperawatan pada pasien.

Komponen keterlibatan adalah kunci untuk diperhatikan dalam mengimplementasikan budaya organisasi. Keterlibatan adalah faktor kunci dalam budaya organisasi, yang merupakan karakteristik nilai dari organisasi yang menempatkan pandangan tentang pentingnya keterlibatan seluruh pegawai yang bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi (Tika, 2006). Sebagian besar persepsi perawat pelaksana tentang keterlibatan adalah baik (76.7%). Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Tika (2006) bahwa keterlibatan yang tinggi dari anggota organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi dalam hal ini RSJ Jambi.

Budaya organisasi mempunyai peran penting dalam mempengaruhi setiap anggota organisasi saat menjalankan aktifitas serta dapat dibedakan melalui sistem nilai yang di anut oleh anggota organisasi (Robbins, 2006). Budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi masalah – masalah yang timbul akibat adaptasi

eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik (Asri, 2011). Salah satu upaya untuk mempertahankan budaya organisasi perawat pelaksana yang baik di Rumah Sakit Jiwa Jambi dengan mengkaitkan pemahaman kepada perawat pelaksana khususnya pada komponen budaya organisasi (Keterlibatan, penyesuaian, konsistensi dan misi) dalam menyelesaikan masalah yang ditemui didalam rutinitas keperawatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Selain itu perlunya manajemen RSJ Jambi mensurvey seluruh karyawan termasuk perawat pelaksana untuk memberikan penilaian terhadap budaya organisasi dan budaya kerja yang sudah berjalan selama ini di RSJ Jambi. Hal ini sebagai salah satu bentuk keterlibatan sekaligus memberikan reward terhadap perawat. Budaya organisasi merupakan persepsi perawat pelaksana tentang hal-hal yang mereka rasakan dan lakukan. Budaya organisasi yang baik menjadikan perawat pelaksana mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan (Robbin, 2006). Seseorang yang memiliki budaya organisasi dalam dirinya jika ditunjang dengan kompensasi dan

budaya dalam bekerja yang baik akan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan menjadi lebih optimal. Dalam hal ini disarankan juga agar menggali lebih dalam budaya organisasi perawat pelaksana dalam mendukung emosional agar dapat memperoleh budaya organisasi lebih baik dalam berkerja. Hal lain yang menjadi hak perawat juga perlu ditunaikan seperti kesempatan untuk meningkatkan pendidikan formal maupun informal, pengembangan kompetensi, penghargaan yang sesuai, dan melaksanakan metode penugasan di ruangan dengan konsisten dan sesuai kaidah. Manajemen rumah sakit perlu mengevaluasi, serta mempertahankan program dalam mengembangkan budaya organisasi yang sudah baik yang ada di ruang rawat inap.

BAB 3

KEPEMIMPINAN PERAWAT

A. Kepemimpinan Perawat

Banyak para ahli mendefinisikan kepemimpinan, dari dulu sampai sekarang yang semakin menunjukkan ke arah kesempurnaan. Kepemimpinan merujuk pada proses atau kemampuan untuk memimpin dan memandu individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi. Kepemimpinan melibatkan komunikasi efektif, inspirasi, pengambilan keputusan, menjadi contoh peran, serta kemampuan untuk memotivasi dan membimbing anggota tim.

Pengertian kepemimpinan adalah: proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. Kepemimpinan adalah proses memberdayakan kepercayaan dan mengajarkan orang lain untuk menggunakan seluruh kemampuannya (Robbins, & Judge 2024). Zhu, Jiweng et.al, (2019) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian visi atau serangkaian tujuan (Lord, Day, 2017).

Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain dengan proses persuasi sehingga bersedia dengan antusias untuk mencapai tujuan institusi.

Perawat berperan penting dalam pengembangan sistem layanan kesehatan modern, dan berperan sebagai pilar dalam industri ini. Mengingat tantangan saat ini terkait dengan kekurangan tenaga kesehatan, para pemimpin harus dengan cerdas mengadopsi berbagai gaya kepemimpinan dan strategi pemberdayaan staf untuk menciptakan lingkungan kerja yang menumbuhkan komitmen di antara staf perawat, pasien, dan organisasi mereka. Hubungan antara gaya kepemimpinan dan pemberdayaan staf merupakan bagian integral, karena mempengaruhi tingkat komitmen di antara staf keperawatan. Yang paling penting adalah tantangan-tantangan yang sedang berlangsung akibat kekurangan tenaga kesehatan, terutama dalam profesi keperawatan. Perawat dan teknisi layanan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pemberian layanan kesehatan, baik untuk pasien individu maupun kelompok yang menderita penyakit yang sama. Dengan memanfaatkan kompetensi mereka, pemimpin perawat berkolaborasi dengan profesional layanan kesehatan lainnya untuk mengurangi biaya layanan kesehatan secara keseluruhan.

B. Gaya Kepemimpinan

Faktor penentu sebuah keberhasilan dan kesinambungan suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan ini dapat dipergunakan kapan saja untuk menyelesaikan suatu persoalan yang menyangkut organisasi. Gaya kepemimpinan seorang pimpinan yang berkualitas akan mampu menjawab tantangan dan persoalan suatu organisasi dalam upaya mencapai kinerja karyawan yang baik. Pendekatan atau gaya kepemimpinan yang akan digunakan oleh seorang pemimpin akan turut mempengaruhi keberhasilan pemimpin itu sendiri melalui otoritas dan kewenangan yang dimilikinya dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang dipimpinnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja yang dicapai oleh suatu karyawan. Oleh karena itu potret dari seorang pimpinan akan dapat terlihat dari kinerja bawahannya.

Goleman (2016) menyatakan pemimpin yang baik adalah efektif, karena mereka menciptakan resonance, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan dapat mengarahkan emosi orang lain kearah yang positif. Pemimpin yang baik akan berbicara secara otentik tentang nilai (*values*), tujuan dan prioritasnya serta dapat menyuarakan perasaan orang disekitarnya. Sedangkan Stoner, et al (1996), mengemukakan untuk

dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif, pemimpin itu harus memilih gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga pegawai pun dapat meningkatkan kinerjanya.

Gaya dapat diartikan sebagai penampilan karakteristik tersendiri atau khusus (Gillies, 1996, dalam Nursalam 2014). Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang dapat ditampilkan seorang pimpinan ketika pemimpin itu mencoba mempengaruhi perilaku orang lain dalam berbagai situasi (Stoner, et al, 1996 dalam Nursalam 2014).

Perilaku pemimpin itu sendiri dipengaruhi oleh adanya pengalaman bertahun-tahun dalam hidupnya. Karenanya kepribadian seseorang akan mempengaruhi gaya kepemimpinan yang digunakan, sehingga seorang pemimpin akan mempunyai gaya kepemimpinan yang bervariasi dan cenderung berbeda-beda, yang tentunya akan mempengaruhi perilaku bawahannya. Perilaku yang diperlihatkan oleh bawahan pada dasarnya sebagai respon terhadap gaya kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin kepada staf dalam rangka melakukan proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

BAB 4

KINERJA KEPERAWATAN

A. Pengertian Kinerja Keperawatan

Kinerja dalam Keperawatan merupakan bentuk penilaian kerja yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan. Kinerja diartikan dalam beberapa arti penting diantaranya adalah sebagai berikut: kinerja berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan), sedangkan kinerja menurut beberapa teori seperti *theory Dennis W organ* yang membedakan antara kinerja yang tergantung perannya dan perilaku yang spontan dan inovatif (Fathoni, 2016). Sedang menurut *organizational Citizen ship behavior (OCB)* mengonsepan bahwa kinerja karyawan, kecerdasan spiritual, kepemimpinan, dan budaya organisasi yang tersusun dalam serangkaian ilmu perilaku organisasi. *Gibson Theori* menjelaskan kinerja sebagai keberhasilan menyelesaikan tugas atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Kinerja diartikan juga sebagai kombinasi dari efektifitas dengan efisiensi pada saat melakukan tugas pokok pekerjaan

sehingga memberikan kontribusi pada produksi suatu barang atau jasa. (Robbin, 2015).

Dasar dari beberapa teori dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja adalah segala sesuatu perilaku spontan, efektifitas, efisiensi inovasi sebagai keberhasilan menyelesaikan tugas atau memenuhi target yang dinilai oleh pimpinan kepada bawahan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi dengan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi dengan kinerja menurut Davis (1964) dalam mangkunegara (2009) menjelaskan bahwa factor yang mempengaruhi kinerja adalah factor kemampuan, dan motivasi Faktor. Atmosoeprapto (2001) dalam Zubaidah (2007) menjabarkan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Yang termasuk dalam faktor internal adalah tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, budaya organisasi, sedangkan faktor eksternal Faktor internal. faktor yang mempengaruhi kinerja menurut beberapa hasil penelitian diantaranya adalah motivasi, etos kerja, lingkungan kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja, serta fungsi manajemen kepala ruangan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor politik (berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan kekuatan negara yang berpengaruh terhadap

keamanan dan ketentuan organisasi untuk berkarya), faktor ekonomi (tingginya perkembangan ekonomi yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor sektor lain sebagai suatu sistem, faktor sosial (orientasi nilai yang berkembang dimasyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja.

Beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang faktor- faktor yang berhubungan dengan kinerja adalah sebagai berikut; hasil penelitian menurut Supriyadi (2017) motivasi, etos kerja, lingkungan kerja, kompetensi dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja perawat. Hasil penelitian Tulasi (2021) menunjukkan bahwa factor yang berhubungan dengan kinerja adalah motivasi, kompensasi, reward (penghargaan), dan workload. Selanjutnya hasil penelitian Taslim (2023) menjelaskan bahwa factor motivasi, fasilitas, pengetahuan, dan gaya kepemimpinan berhubungan dengan kinerja perawat. Menurut Maimun (2016) menyebutkan bahwa motivasi, pengalaman kerja dan kompensasi berhubungan dengan kinerja perawat.

Penelitian berikut adalah hasil penelitian tentang faktor budaya organisasi dengan kinerja diantaranya menurut Utami (2020) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja keperawatan hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Insan (2016) tentang pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif, lingkungan kerja , kompensasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan RSUD Tugurejo. Penelitian yang sama dilakukan oleh sari (2009) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dengan kinerja. Hasil penelitian selanjutnya adalah penelitian Tamuntuan (2021) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara disiplin kerja, motivasi kerja, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja pegawai administrasi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa factor yang berhubungan dengan kinerja perawat yaitu

1. Bersumber dari Internal Perawat diantaranya adalah motivasi, disiplin kerja, etos kerja, kompetensi, kepuasan kerja, pengetahuan, sikap, pengalaman kerja.
2. Bersumber dari Eksternal Perawat yaitu lingkungan kerja kompensasi reward (penghargaan), *workload* (beban kerja), gaya kepemimpinan fasilitas budaya organisasi, dan supervisi.

Faktor motivasi menjadi faktor internal dalam menentukan kinerja perawat, semakin baik motivasi perawat dalam menjalankan tugasnya, maka akan semakin baik pula kinerjanya. Motivasi dapat diartikan

sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya. Seseorang akan melakukan pekerjaan lebih semangat jika ada kebutuhan di dalamnya. Contoh kecil seseorang membutuhkan uang untuk hidup, untuk mendapatkan uang seseorang tersebut akan rela melakukan pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang. Sesuai dengan yang disampaikan Nursalam, ada tiga unsur motivasi yaitu kebutuhan, dorongan dan tujuan. (Nursalam, 2014)

Nursalam (2014) menyebutkan bahwa motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong seseorang melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan, terutama dalam berperilaku. Motivasi bertujuan untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan dapat mencapai tujuan tertentu. Motivasi berdasarkan bentuk terbagi dua yaitu motivasi internal atau bersumber dari dalam diri seseorang sendiri dan motivasi eksternal atau ekstrinsik yaitu motivasi yang

muncul atas adanya support dari orang lain atau diluar dirinya, seperti keluarga.

Disiplin kerja dan etos kerja juga merupakan faktor intrinsik dalam diri perawat yang berhubungan dengan kinerja. Semakin disiplin seseorang, maka akan baik kinerjanya. Seseorang yang disiplin artinya mampu mengatur waktu sehingga pekerjaan yang dikerjakan dapat terselesaikan tepat waktu. Seseorang yang memiliki disiplin tinggi akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diembannya. Seseorang yang disiplin selalu taat, patuh dan memiliki tanggung jawab yang tinggi, sehingga kualitas kerja terjamin. Hasil penelitian Riyanti (2020) tentang disiplin kerja, etos kerja dan kesempatan berprestasi dengan produktivitas kerja perawat rumah sakit memaparkan bahwa ada hubungan antara kesempatan berprestasi, etos kerja dan disiplin kerja dengan kinerja.

Faktor lain yang berhubungan dengan kinerja adalah kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat diobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan. (PPNI, 2013). Perawat yang memiliki kompetensi yang cukup atau baik, akan memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan perawat yang tidak memiliki kompetensi.

Faktor internal atau yang bersumber dari dalam diri perawat adalah faktor kepuasan kerja. Menurut hasil penelitian Budhiana (2022) menjelaskan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kepuasan kerja dengan kinerja artinya semakin puas seseorang, maka semakin baik kinerjanya. Seseorang yang memiliki sikap puas terhadap pekerjaannya akan merasa senang dan semangat dalam mengerjakan tugas yang diembannya.

Selain faktor diatas, ada beberapa factor eksternal yang mempengaruhi kinerja yaitu gaya kepemimpinan. Hasil penelitian Sari (2009) menunjukkan bahwa ada hubungan antara budaya organisasi dan gaya kepemimpinan Kepala ruang dengan kinerja.

C. Penilaian Kinerja

Untuk mendapatkan hasil kerja perawat baik atau tidak, maka perlu dilakukannya penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja dengan langkah- langkah sebagai berikut: mereview standar kerja, melakukan analisis jabatan, mengembangkan instrumen penilaian, memilih penilai, melatih penilai, mengukur kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, mengkaji hasil penilaian, memberikan hasil penilaian, mengaitkan imbalan dengan kinerja, membuat rencana-rencana pengembangan dengan menyepakati

sasaran dan standar- standar kinerja masa depan (Usman, 2011).

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi atau tingkat keberhasilan atau kegagalan seorang pekerja/karyawan atau tim kerja dalam melaksanakan tugas/jabatan yang menjadi tanggung jawabnya (Nawawi, 2006). Sedangkan menurut Nursalam (2008), manfaat dari penilaian kerja yaitu:

1. Meningkatkan prestasi kerja staf secara individu atau kelompok dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian tujuan pelayanan di rumah sakit.
2. Peningkatan yang terjadi pada prestasi staf secara perorangan pada gilirannya akan mempengaruhi atau mendorong sumber daya manusia secara keseluruhannya.
3. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi dengan cara memberikan umpan balik kepada mereka tentang prestasinya.
2. Membantu rumah sakit untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat guna, sehingga rumah sakit akan mempunyai tenaga yang cakap dan tampil untuk

pengembangan pelayanan keperawatan di masa depan.

Proses penilaian kinerja dapat digunakan secara efektif dalam mengarahkan perilaku pegawai, dalam rangka menghasilkan jasa keperawatan dalam kualitas dan volume yang tinggi. Perawat manajer dapat menggunakan proses operasional kinerja untuk mengatur arah kerja dalam memilih, melatih, membimbing perencanaan karier serta memberi penghargaan kepada perawat yang berkompeten (Nursalam, 2008). Proses penilaian kinerja dengan langkahlangkah sebagai berikut: mereview standar kerja, melakukan analisis jabatan, mengembangkan instrumen penilaian, memilih penilai, melatih penilai, mengukur kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, mengkaji hasil penilaian, memberikan hasil penilaian, mengaitkan imbalan dengan kinerja, membuat rencana-rencana pengembangan dengan menyepakati sasaransasaran dan standar-standar kinerja masa depan (Usman, 2011). Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui supervise. Supervise merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi kinerja seorang perawat.

Supervisi yang benar dan memiliki standar serta format supervise yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kualitas kerja. Supervise itu sendiri

diartikan sebagai bentuk pengamatan secara langsung oleh atasan yang dilakukan secara berkala terhadap bawahannya. Kegiatan supervisi dilakukan dengan memonitor kegiatan atau tugas bawahannya sesuai dengan format penilaian yang sudah diterbitkan oleh rumah sakit. Jika dalam proses penilaian ada yang tidak sesuai dengan standar, maka pimpinan berhak memberikan bimbingan dan arahan agar kegiatan yang dilakukan sesuai standard an tujuan organisasi.

D. Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi atau tingkat keberhasilan atau kegagalan seorang pekerja/karyawan atau tim kerja dalam melaksanakan tugas/jabatan yang menjadi tanggung jawabnya (Nawawi, 2006). Sedangkan menurut Nursalam (2008), manfaat dari penilaian kerja yaitu:

1. Meningkatkan prestasi kerja staf secara individu atau kelompok dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian tujuan pelayanan di rumah sakit.
2. Peningkatan yang terjadi pada prestasi staf secara perorangan pada gilirannya akan mempengaruhi

- atau mendorong sumber daya manusia secara keseluruhannya.
3. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi dengan cara memberikan umpan balik kepada mereka tentang prestasinya.
 4. Membanturumahsakituntukdapatmenyusunprogrampengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat guna, sehingga rumah sakit akan mempunyai tenaga yang cakap dan tampil untuk pengembangan pelayanan keperawatan di masa depan.
 5. Memberikan kesempatan kepada pegawai atau perasaannya tentang pekerjaannya atau hal lain melalui jalur komunikasi dan dialog, sehingga antara atasan dan bawahan.

E. Standar Penilaian Kinerja

Standar Kinerja adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pekerjaan, proses, atau aktivitas telah menentukan target atau harapan yang ditetapkan. sejumlah kriteria yang menjadi penilaian kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan/jabatan (Nawawi, Timpe (1988, dalam Usman 2011) menyatakan bahwa dibuat untuk setiap individu dengan berpedoman pada penulisan standar dimulai

ketika pengawas dan pegawai pekerjaan. Langkah pertama meliputi penulisan semua jawab karyawan. Pegawai juga mempertimbangkan tentang harapan-harapan utama yang mungkin dimiliki menyelesaikan proses penulisan, penyuntingan dan integrasi, yang disepakati untuk dituliskan dan dapat dikuantifikasikan dicapai. Agar standar penilaian dilakukan sama dan terstandar, maka perlu adanya panduan penilaian kinerja di rumah sakit.

Proses pelayanan keperawatan yang sesuai standar dan melalui proses supervise dan penilaian kinerja akan berdampak pada mutu layanan dan kepuasan kerja serta kepuasan pasien pada akhirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, F. N., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2021). The relationship between environmental sanitation of family and stunting among under-five children: A cross-sectional study in the public health center of jember, indonesia. *Nursing Practice Today*, 8(3), 173–178. <https://doi.org/10.18502/npt.v8i3.5932>
- Alexander, S., Ostfeld, R. J., Allen, K., & Williams, K. A. (2017). A plant-based diet and hypertension. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 327–330. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.014>
- Aljuraiban, G., Chan, Q., Gibson, R., Stamler, J., Daviglus, M. L., Dyer, A. R., Miura, K., Wu, Y., Ueshima, H., Zhao, L., Van Horn, L., Elliott, P., & Oude Griep, L. M. (2020). Association between plant-based diets and blood pressure in the INTERMAP study. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 3(2), 133–142. <https://doi.org/10.1136/bmjnp-2020-000077>
- Allender, J. A., & Spardley, B. W. (2011). *Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Anderson, E., & Mc Farlane, J. (2004). *Community As Partner: Theory and Practice in Nursing* (4th Editio). Lippincott Williams & Wilkins.
- Aristi, D. L. A., Rasni, H., Susumaningrum, L. A., Susanto, T., & Siswoyo, S. (2020). Hubungan Konsumsi Makanan

Tinggi Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Buruh Tani di Wilayah Kerja Puskesmas Panti Kabupaten Jember. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(1), 53–60. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i1.2741>

Asmawati, Ambar Sari, D., Ihromi, S., Nurhayati, Pacitra, S., Danela Luthfiah, T., & Rizal, H. (2021). Cegah Stunting Dan Gizi Buruk Pada Balita Dengan Edukasi Gizi Bagi Tumbuh Kembang Anak Di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 2(2), 7–12. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm>

Budiwibowo, S. (2016). Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 3(01), 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>

Dinkes Jawa Timur. (2020). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019. *Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, 1–73. www.dinkesjatengprov.go.id

Gupta, A. K., Mongia, M., & Garg, A. K. G. (2018). A descriptive study of behavioral problems in schoolgoing children. *Industrial Psychiatry Journal*, 195–201. <https://doi.org/10.4103/ipj.ipj>

Halder, S., & Kejriwal, S. (2016). Nutritional awareness of mothers in relation to nutritional status of the preschool children. *Early Child Development and Care*, 186(9), 366–377.

- Handayani, D., Kusuma, E., Puspitasari, H., & Nastiti, A. D. (2022). The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Coastal Areas. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(3), 755–764. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i3.967>
- Harahap, R. A., Rochadi, R. K., & Sarumpae, S. (2018). Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Laki-Laki Dewasa Awal (18-40 Tahun) Di Wilayah Puskesmas Bromo Medan Tahun 2017. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i2.951>
- Hever, J., & Cronise, R. J. (2017). Plant-based nutrition for healthcare professionals: Implementing diet as a primary modality in the prevention and treatment of chronic disease. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 355–368. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.012>
- Isnaini, A. F., Susanto, T., Susumaningrung, L. A., Rasni, H., & Siswayo, S. (2020). Hubungan fungsi keluarga dengan status gizi balita pada keluarga tiri di kecamatan panti kabupaten jember. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 3(1), 1–10.
- Joshi, S., Hashmi, S., Shah, S., & Kalantar-Zadeh, K. (2020). Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease. *Current Opinion in Nephrology and Hypertension*, 29(1), 16–21.

<https://doi.org/10.1097/MNH.0000000000000574>

- Kavosi, E., Rostami, Z., Kavosi, Z., Nasihatkon, A., Moghadami, M., & Heidari, M. (2014). Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in Fars province. *Iran Int J Health Policy Manag*, 3(2), 71–76.
- Kemendes RI. (2016). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga* (Vol. 21, Issue 1). Kementerian Kesehatan RI. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Mila Triana Sari. 2009. Hubungan Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Kepala ruangan di Rumah Sakit. Disertasi> universitas Indonesia
- Munir Miftahul. 2020. Monograf Organization Citizenship Behaviour terhadap Kinerja Perawat. CV Pena Persada. Jawa Tengah
- Mutmainnah. 2020. Manajemen Keperawatan; Perawat, kinerja, Motivasi dan Remunerasi. CV Adanu Abimata. Jawa Barat
- Nursalam. 2014. Manajemen Keperawatan; Aplikasi dalam keperawatan Profesional. Salemba Medika. Jakarta.
- Riyanti. 2020. Disiplin Kerja, Etos Kerja, dan Kesempatan berprestasi dengan produktifitas kerja perawat Rumah Sakit Holistik. *Jurnal Kesehatan* vol 14 no 3.
- Supriyadi. 2017. Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat Rumah Sakit Islam PDHI Yogyakarta. *Health Sciences and Pharmacy Journal*. Volume 1

No 1.

Tamuntuan.2021. faktor faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat administrasi Rumah Sakit di era New Normal. Inti sari sains Media Vol 12 no 2.

Tulasi Marcelinus. 2021, Faktor 2021. Faktor yang berhubungan dengan Kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefarmenani, Kalimantan. Media Kesehatan Masyarakat. Kupang

GLOSARIUM

B

Budaya Organisasi: Sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu organisasi yang memengaruhi cara kerja, komunikasi, dan hubungan antar anggota organisasi.

G

Gaya Kepemimpinan: Cara seorang pemimpin berinteraksi dan mempengaruhi bawahannya.

K

Kepemimpinan: Proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Kepuasan Kerja: Tingkat kepuasan perawat terhadap pekerjaan mereka.

Kinerja Perawat: Tingkat efektivitas dan efisiensi perawat dalam menjalankan tugas-tugas profesional mereka, yang mencakup pelayanan pasien, kolaborasi dengan tim medis, dan penerapan standar profesi.

Kolaborasi Tim: Kerja sama antar profesi dan individu dalam organisasi rumah sakit untuk mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien.

Komitmen Organisasi: Tingkat keterikatan emosional perawat terhadap organisasi.

Konflik: Perbedaan pendapat atau kepentingan yang dapat mengganggu kinerja organisasi.

Kualitas Pelayanan: Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

M

Motivasi Kerja: Faktor-faktor yang memotivasi individu untuk bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi, baik yang berasal dari internal diri perawat itu sendiri maupun dari lingkungan kerja.

N

Nilai-nilai: Prinsip-prinsip dasar yang diyakini dan dihargai oleh organisasi.

Norma: Aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota organisasi.

P

Profesionalisme: Sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap standar etika, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan tugas profesi.

Perubahan Organisasi: Proses yang melibatkan upaya untuk memperbaiki atau mengubah struktur, budaya, dan prosedur di dalam suatu organisasi guna meningkatkan kinerja dan efisiensi.

R

Rumah Sakit: Institusi pelayanan kesehatan yang memberikan perawatan medis untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

S

Servant Leadership: Kepemimpinan yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan pengikut di atas kepentingan diri sendiri.

Sosialisasi Organisasi: Proses di mana individu baru belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan perilaku organisasi.

Supervisi : bentuk pengamatan secara langsung oleh atasan yang dilakukan secara berkala terhadap bawahannya.

PROFIL PENULIS



Ns. Mila Triana Sari, M.Kep., Lahir di Jambi. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang SI pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali sejak tahun 1995 di Akper Baiturrahim Jambi, tahun 2005 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim. Saat ini penulis bekerja di Universitas Baiturrahim Jambi, mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Metodologi Penelitian, Keperawatan Keluarga, Kewirausahaan, dan Pelayanan Prima. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai pengajar, melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, juga publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional dan seminar Nasional dan Internasional baik sebagai peserta maupun pembicara. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: milatrianasari73@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Daryanto, SKP., M.Kep., Lahir di Jambi, 20 Juli 1966, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh penulis yaitu jenjang SI pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tamat tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia, lulus tahun 2007.

Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Jambi, mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa, Psikologi Keperawatan, Komunikasi dalam Keperawatan dan Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai pengajar, penulis buku, melakukan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, juga publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional, dan seminar Nasional dan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: daryanto2766@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Miko Eka Putri, M.Kep., Ns. Miko Eka Putri, M.Kep lahir di Jambi 29 April 1984. Penulis merupakan salah satu dosen tetap di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Baiturrahim Jambi. Adapun riwayat pendidikan sarjana Di Universitas Andalas Padang tahun 2005, dan jenjang magister keperawatan spesifikasi manajemen keperawatan di Universitas

Diponegoro Semarang tahun 2012. Memiliki 4 orang anak (3 laki- laki dan 1 orang perempuan). Lebih dari 14 Tahun mengajar di Universitas Baiturrahim memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis dalam mengaplikasikan tridarma perguruan tinggi. Pengalaman mengajar pada mata kuliah manajemen keperawatan, keperawatan keluarga, komunikasi keperawatan, keperawatan komunitas dan system informasi keperawatan. Penulis aktif dalam menulis buku, publikasi jurnal nasional dan jurnal internasional. Untuk menghubungi penulis dapat pada email putrieka2904@gmail.com .

SINOPSIS BUKU

Buku "**Implementasi Budaya Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Rumah Sakit**" membahas tentang pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Buku ini menjelaskan bagaimana budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan profitabilitas rumah sakit.

Buku ini juga membahas tentang bagaimana mengimplementasikan budaya organisasi yang positif di rumah sakit. Beberapa strategi yang dibahas meliputi:

membangun visi dan misi yang jelas, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan, memfasilitasi pengembangan profesional karyawan, dan membangun sistem manajemen kinerja yang efektif.

Buku ini ditujukan untuk para pemimpin rumah sakit, manajer, dan karyawan yang ingin meningkatkan kinerja rumah sakit. Buku ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa manajemen kesehatan dan profesional kesehatan lainnya yang tertarik dengan topik budaya organisasi dan kinerja rumah sakit.

Manfaat membaca buku ini:

Memahami pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja rumah sakit, mempelajari strategi untuk mengimplementasikan budaya organisasi yang positif di rumah sakit, meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan, meningkatkan kualitas layanan rumah sakit, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan efisiensi operasional

rumah sakit, dan meningkatkan profitabilitas rumah sakit.

Buku "Implementasi Budaya Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Rumah Sakit" membahas tentang pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Buku ini menjelaskan bagaimana budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan profitabilitas rumah sakit.

Buku ini juga membahas tentang bagaimana mengimplementasikan budaya organisasi yang positif di rumah sakit. Beberapa strategi yang dibahas meliputi: membangun visi dan misi yang jelas, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan, memfasilitasi pengembangan profesional karyawan, dan membangun sistem manajemen kinerja yang efektif.

Buku ini ditujukan untuk para pemimpin rumah sakit, manajer, dan karyawan yang ingin meningkatkan kinerja rumah sakit. Buku ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa manajemen kesehatan dan profesional kesehatan lainnya yang tertarik dengan topik budaya organisasi dan kinerja rumah sakit.

Manfaat membaca buku ini: Memahami pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja rumah sakit, mempelajari strategi untuk mengimplementasikan budaya organisasi yang positif di rumah sakit, meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan, meningkatkan kualitas layanan rumah sakit, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, dan meningkatkan profitabilitas rumah sakit.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7097-85-9



9

786347

097859

